

SECRETARIA DA
SAÚDE



GOVERNO
DO ESTADO
**RIO
GRANDE
DO SUL**

Indicadores PIAPS

Janeiro de 2026



PRINCÍPIOS QUE NORTEARAM A CONSTRUÇÃO DO PIAPS

- Garantir os recursos da APS aos municípios;
- Manutenção do repasse per capita - atenção especial às populações específicas;
- Incentivo às equipes eSF, eSB, eAP, eCR, eAPP
- Indicadores de qualificação de processo e cuidado;
- Equidade no repasse de valores incorporados;
- Afirmar e reforçar estratégias de cuidado que compõem a APS do estado: Comunidades Quilombolas, os Povos Indígenas, as Equipes de Atenção Básica Prisional, Equipes de Consultório na Rua e o Primeira Infância Melhor (PIM).
- Componente Qualificação da APS: Rede Bem Cuidar RS .

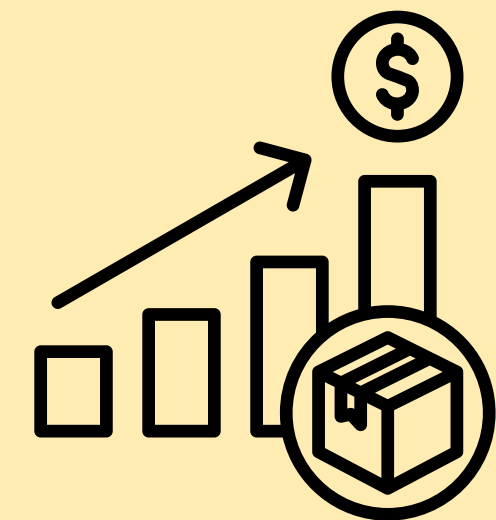


OS 5 COMPONENTES

- I - Sociodemográfico;
- II - Incentivo para equipes de Atenção Primária à Saúde;
- III - Incentivo à Promoção da Equidade em Saúde;
- IV - Incentivo ao Primeira Infância Melhor
- V - Estratégico de incentivo à qualificação da APS

RECURSO PREVISTO PARA O ANO DE 2026

R\$ 395.087.803,31



Aumento de
7,6% em relação
a 2025



PRINCIPAIS ALTERAÇÕES 2026 - COMPONENTE SOCIODEMOGRÁFICO

- **Revisão geral do componente** com base em fontes atualizadas como o Censo IBGE 2022, RPSA 2024



Novidade - População Rural:

- municípios com população rural maior ou igual a 60%: repasse de **R\$ 5,19/habitante**.
 - **Acréscimo de R\$ 1.354.491,39**
- **Atualização repasse per capita população migrante:** de R\$ 5,19 para **R\$ 6,72**.



PRINCIPAIS ALTERAÇÕES 2026 - COMPONENTE DE INCENTIVO PARA EQUIPES DE APS



NOVOS INDICADORES

- 
1. **Percentual de pessoas entre 40 e 74 anos com estratificação de risco cardiovascular na APS**
 2. **Percentual de pessoas idosas com registro do procedimento “Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa”.**

- Equipes de Saúde Bucal:
 - **eSB 40h** de R\$850,00 para R\$ 1.200,00
 - **eSB 20/30h** de R\$850,00 para R\$ 1.000,00
- Reforço no cofinanciamento diferenciado por carga horária de forma a priorizar eSB 40h
- Atualização de 13 para 19 equipes de Consultório na Rua (eCR)



PRINCIPAIS ALTERAÇÕES 2026 - COMPONENTE DE INCENTIVO DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE

SEÇÃO I - PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ENFRENTAMENTO DO RACISMO, DO RACISMO INSTITUCIONAL E DA XENOFOBIA

R\$ 300.000,00

SEÇÃO II - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO REMANESCENTE DE QUILOMBOS

R\$ 2.976.400,00 **R\$ 3.100.800,00 (2026)**

SEÇÃO III - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE AOS POVOS INDÍGENAS

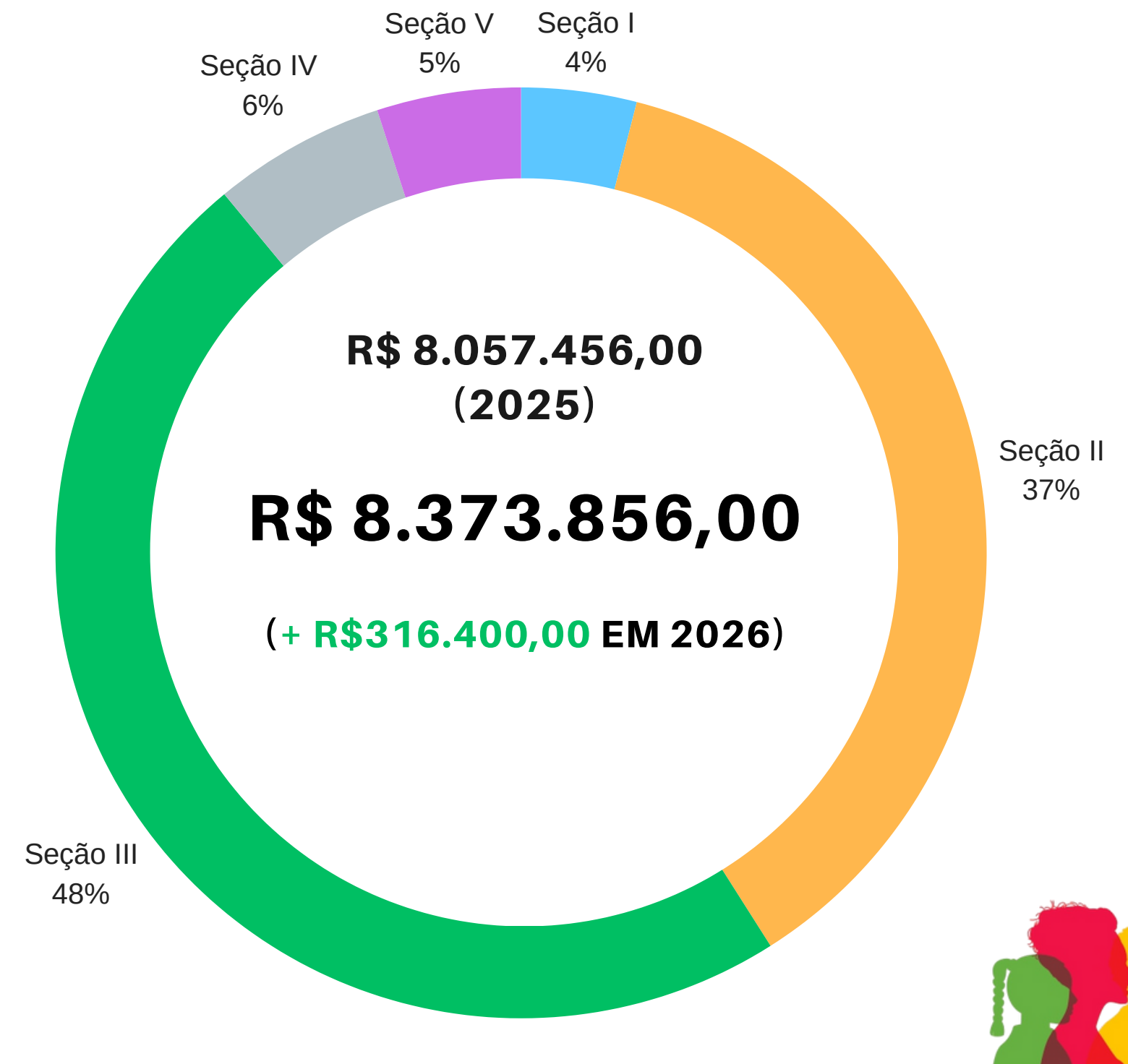
R\$ 3.840.000,00 **R\$ 4.032.000,00 (2026)**

SEÇÃO IV - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO MIGRANTE INTERNACIONAL

R\$ 506.056,00

SEÇÃO V - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBT

R\$ 435.000,00



PRINCIPAIS ALTERAÇÕES 2026 - INDICADORES 2026

SEM DESCONTO

- Indicador de Alimentação Saudável (sem alteração)



- Indicador de PICS (com alteração)



- Indicador de Saúde Mental (com alteração)

COM DESCONTO

- Gestantes com prescrição adequada para tratamento de sífilis (sem alteração)



- Indicador de ERC (NOVO)



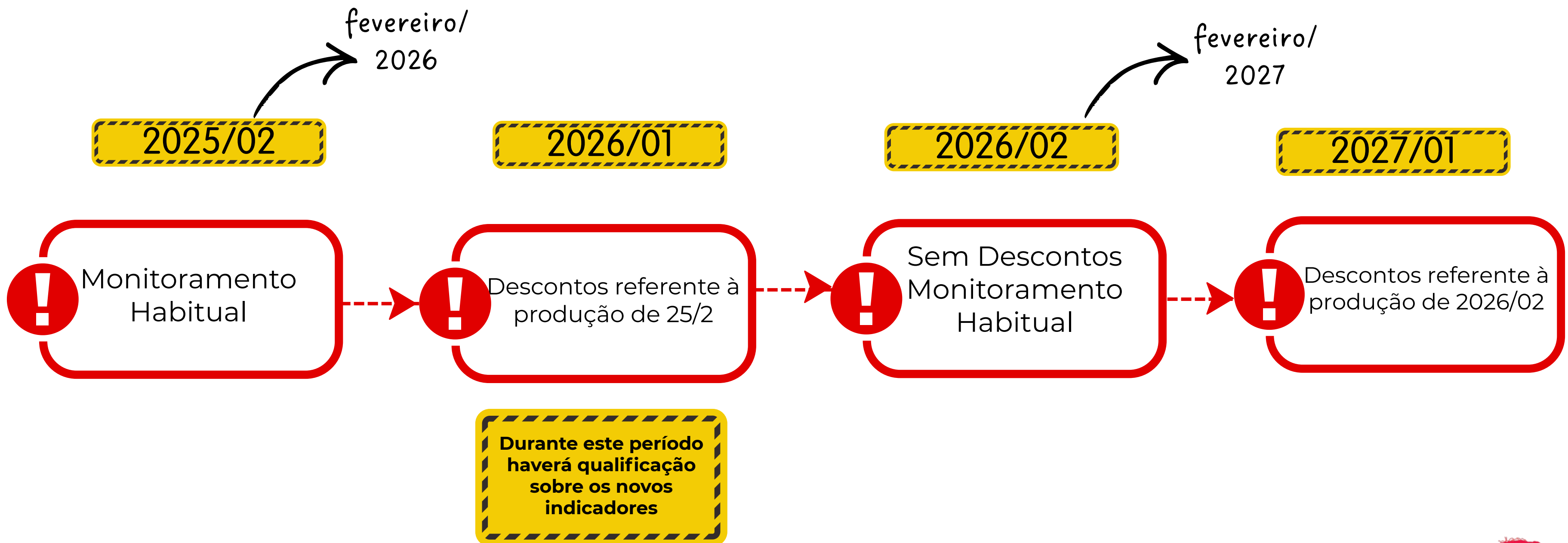
- Indicador de Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (NOVO)

Os descontos continuam no percentual de 5% por indicador no repasse destinado às eSF e eAP

máximo de 15% de desconto no Componente II



PRINCIPAIS ALTERAÇÕES 2026 - LINHA DO TEMPO MONITORAMENTO INDICADORES



PRINCIPAIS ALTERAÇÕES 2026 - LINHA DO TEMPO MONITORAMENTO INDICADORES

RESUMINDO



2026/01 Monitoramento de novos indicadores sem acarretar descontos no próximo semestre (Período de aprendizagem e treinamento)

2026/02 Monitoramento com produção contabilizando para desconto no próximo semestre

Atenção! A produção do 2º semestre 2026 contabilizará para descontos em 2027/01!



MATERIAIS DISPONÍVEIS

CONSULTE VÍDEOS, NOTAS,
PAINEL E DEMAIS INFORMAÇÕES
SOBRE OS INDICADORES AQUI!



GUIA ORIENTADOR PARA REGISTRO
DE ATIVIDADES



PERCENTUAL DE PESSOAS IDOSAS COM REGISTRO DE AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DA PESSOA IDOSA

Política de Saúde da Pessoa Idosa

III. Componente de incentivo para equipes da Atenção Primária à Saúde

Indicador nº6 (Novo)	Percentual de Pessoas Idosas com registro do procedimento Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa
Objetivo	Induzir a Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa como uma ferramenta basilar para o acompanhamento de saúde da população idosa no âmbito da Atenção Primária em Saúde.



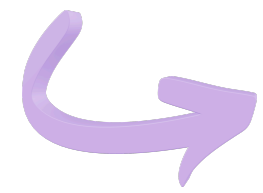
Início do desconto no 1º semestre de 2027
Descontos referente à produção de 2026/02

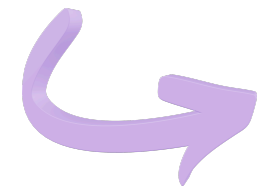


Modelo Multidimensional da Saúde da Pessoa Idosa

- OLHAR PARA ALÉM DA IDADE E DAS PATOLOGIAS:
 - As necessidades biopsicossociais são aquelas tarefas do cotidiano fundamentais para a gestão da própria vida e do autocuidado, que recebem o nome de atividades de vida diária
 - Saúde é definida como a capacidade individual de satisfação das necessidades biopsicossociais, independentemente da idade ou da presença de doenças.

Capacidade funcional

 **Autonomia** - capacidade individual de tomada de decisões sobre sua própria vida

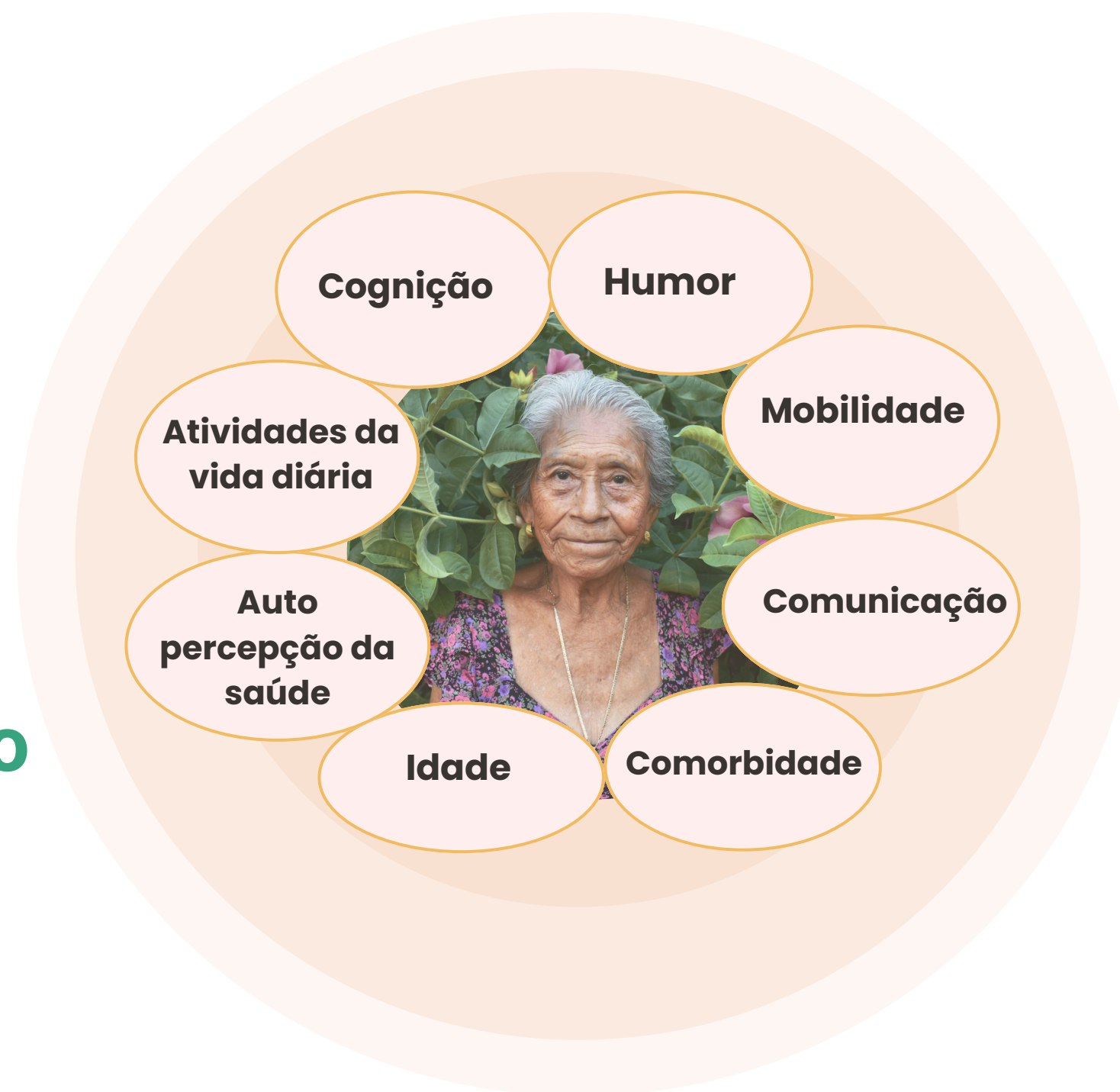
 **Independência** - capacidade de realizar algo por seus próprios meios



Modelo Multidimensional da Saúde da Pessoa Idosa

Autonomia DECISÃO

- cognição;
- linguagem;
- atenção;
- memória;
- humor;
- comportamento



Independência EXECUÇÃO

- mobilidade
- comunicação
- controle de esfíncter
- visão
- audição
- motricidade
- mastigação
- deglutição



Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (AMD)

- Aplicação de instrumento - **Índice de Vulnerabilidade Clínico-funcional 20 (IVCF-20)**
- Identificar o perfil de funcionalidade da pessoa e direcionar os cuidados necessários na rede de atenção à saúde e intersetorial
- Estratificando o risco da pessoa idosa - estratos clínicos funcionais



Processo de fragilização

- comorbidades
- sarcopenia
- dificuldades cognitivas
- maior dependência
- polifarmácia



IVCF-20

- Instrumento de rápida e fácil aplicação a ser conduzido por profissionais de saúde, incluindo agentes comunitários de saúde.
- Contém 20 questões que avaliam 8 dimensões da saúde: idade, autopercepção da saúde, atividades da vida diária, cognição, humor, mobilidade, comunicação e comorbidades múltiplas.
- Ao final da aplicação, a pontuação indicará o perfil de vulnerabilidade obtido:



ÍNDICE DE VULNERABILIDADE CLÍNICO-FUNCIONAL – IVCF-20

IDADE		1. Qual é a sua idade?	☐ 60 a 74 anos (0) ☐ 75 a 84 anos (1) ☐ ≥ 85 anos (3)	Máx. 3 pts
PERCEPÇÃO DE SAÚDE		2. Em geral, comparando com outras pessoas de sua idade, você diria que sua saúde é:	☐ Excelente, muito boa ou boa (0) ☐ Regular ou ruim (1)	Máx. 1 pt
ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA – AVD	AVD Instrumental A pontuação máxima é de 4 pontos, mesmo que a pessoa tenha respondido sim para as questões 3, 4 e 5.	3. Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras? ☐ Sim (4) ☐ Não ou não faz compras por outros motivos que não a saúde (0)		
	4. Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de controlar seu dinheiro, gastos ou pagar as contas de sua casa? ☐ Sim (4) ☐ Não ou não controla o dinheiro por outros motivos que não a saúde (0)			
		5. Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de realizar pequenos trabalhos domésticos, como lavar a louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve? ☐ Sim (4) ☐ Não ou não faz mais pequenos trabalhos domésticos por outros motivos que não a saúde (0)		
AVD Básica		6. Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho? ☐ Sim (6) ☐ Não (0)		
COGNIÇÃO		7. Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido? ☐ Sim (1) ☐ Não (0)		Máx. 3 pts
		8. Você tem um esquecimento que está piorando nos últimos meses? ☐ Sim (1) ☐ Não (0)		
		9. Você tem um esquecimento que está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano?		

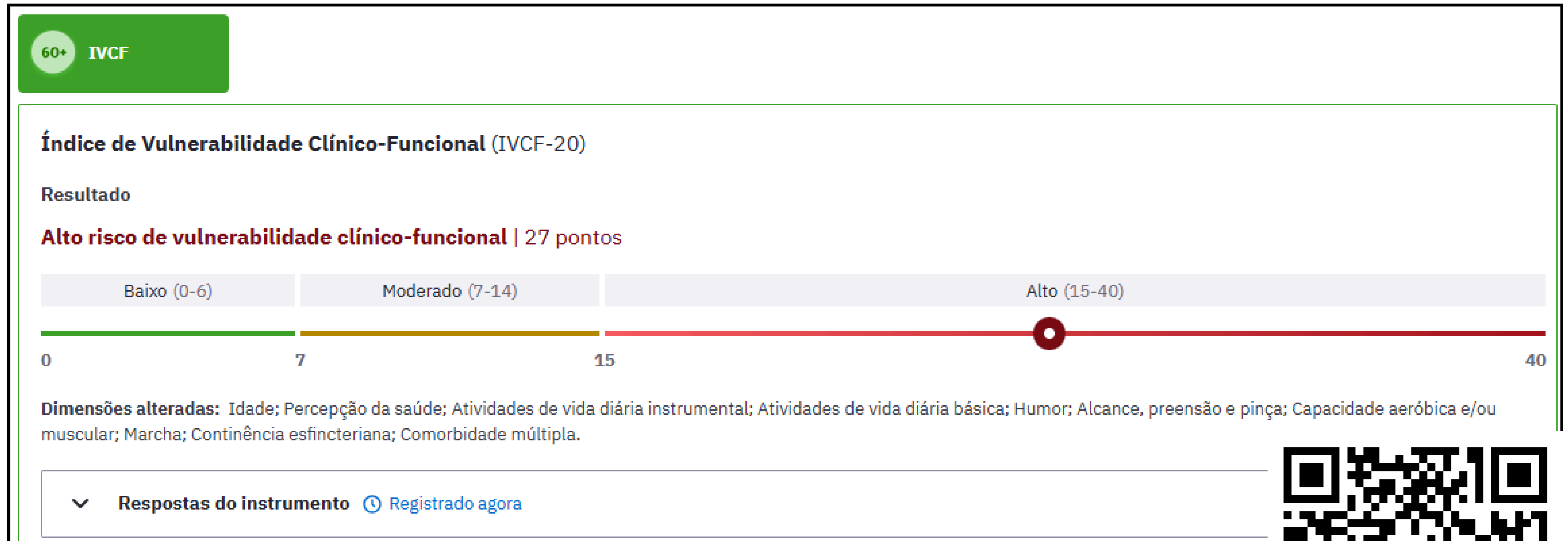


Como realizar?

- **Todos os profissionais da equipe podem aplicar o IVCF-20 -**
 - **ACS, Médicos/as, Enfermeiros/as, Dentistas, demais membros da equipe Multi**
- **Aplicação anual para todas as pessoas idosas e semestral para aquelas em risco de fragilização ou frágeis ou a depender da necessidade**
- **Atendimentos individuais e atendimentos e visitas domiciliares**
- **Construção de PTS a partir do que foi identificado**
- **Uso do PEC permite preenchimento dentro do sistema**
- **Registro por apenas um profissional**



Resultado da aplicação do IVCF-20 no e-SUS



- [Manual de Uso do IVCF-20 no PEC](#) - Manual de uso do módulo de atendimento à pessoa idosa, com inclusão do IVCF-20 no prontuário eletrônico do cidadão (PEC e-SUS APS)



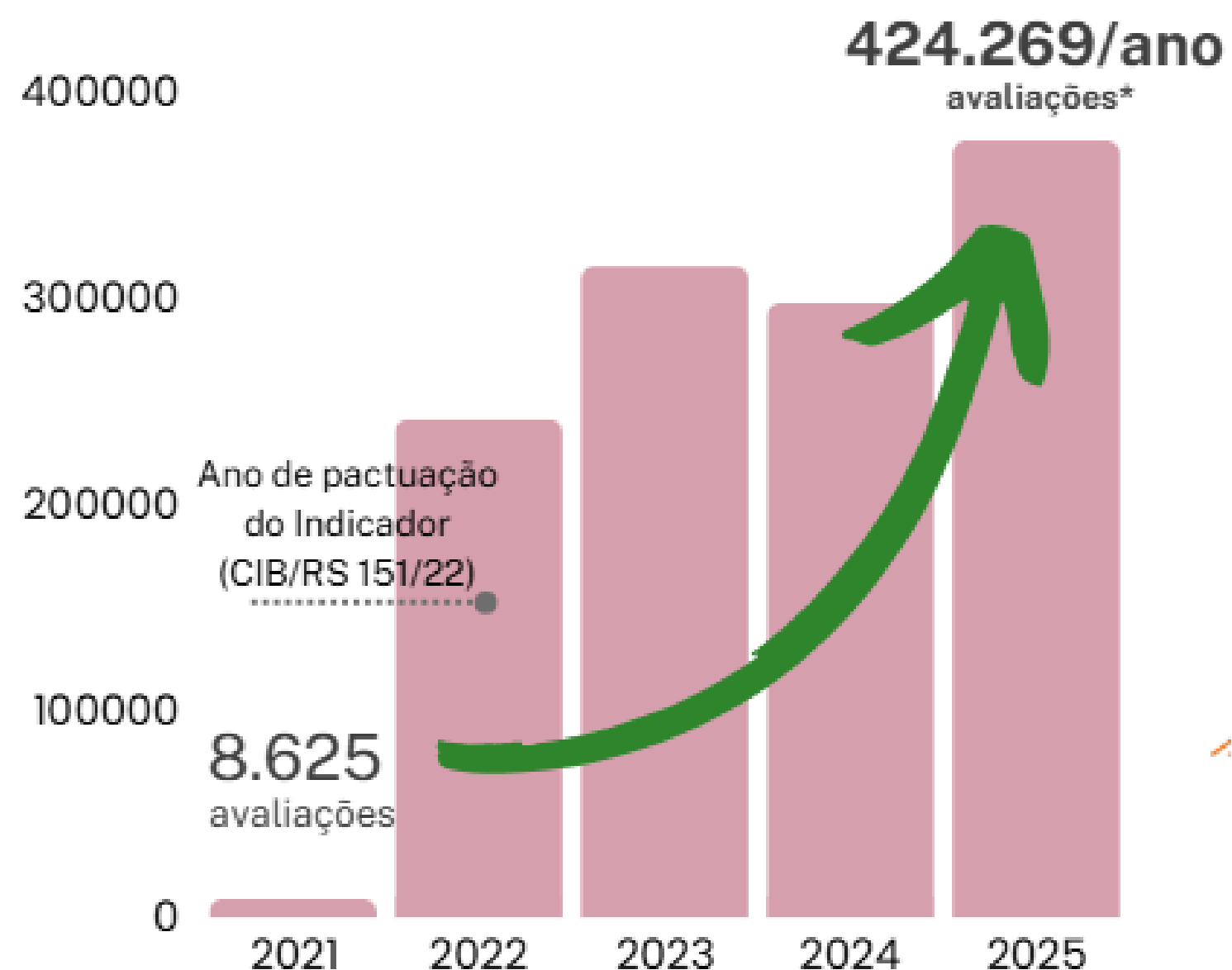
O registro no Sistema de Informação é restrito aos CBOs:

Categoria
1312 - Gestores e especialistas de operações em empresas, secretarias e unidades de serviços de saúde
2212 - Biomédicos
2231 - Médicos
2232 - Cirurgiões-dentistas
2234 - Farmacêuticos
2235 - Enfermeiros e Afins
2236 - Fisioterapeutas
2237 - Nutricionistas
2238 - Fonoaudiólogos
2239 - Terapeutas ocupacionais, ortoptistas e psicomotricistas
2241 - Profissionais da educação física
2251 - Médicos Clínicos
2252 - Médicos em Especialidades Cirúrgicas
2253 - Médicos em Medicina Diagnóstica e Terapêutica
2263 - Profissionais das terapias criativas, equoterápicas e naturológicas
2515 - Psicólogos e psicanalistas
2516 - Assistentes sociais e economistas domésticos



Estratégias para indução da AMD no RS

Histórico de crescimento da AMD no RS



Rede Bem Cuidar (2022 a 2025)

- 389 equipes APS certificadas como UBS Amiga da Pessoa Idosa
- Metas semestrais de AMD 2022-2025: 607 equipes participantes das metas em 2025.



Indicador Bipartite nº 13

- Pactuado com municípios em 2022 (CIB 151/2022)
- Crescimento de 4.819% no nº de AMD desde a introdução do indicador
- Atingimento da Meta de 2025 18% AMD

*Dados Portal BI RS referentes a 2025, coletados em 08/01/2026



Estratégias para indução da AMD no RS



Saúde 60+ RS

- 15 serviços implementados em 2025
- Público-alvo são pessoas **idosas estratificadas como frágeis através da AMD** e/ou com suspeita ou diagnóstico de demência
- Papel matriciador da APS

1. Equipe com médico (a) de Família e Comunidade ou Generalista

- Médico MFC ou Generalista 40h
- Neurologista 8h
- Enfermeiro (a) 40h
- Técnico (a) de enfermagem 40h
- Psicólogo (a) 40h
- Fisioterapeuta 40h
- Assistente Social 40h

OU

2. Equipe com médico (a) Geriatra

- Geriatra 40h
- Neurologista 8h
- Enfermeiro (a) 40h
- Técnico (a) de enfermagem 40h
- Psicólogo (a) 40h
- Fisioterapeuta 40h
- Assistente Social 40h

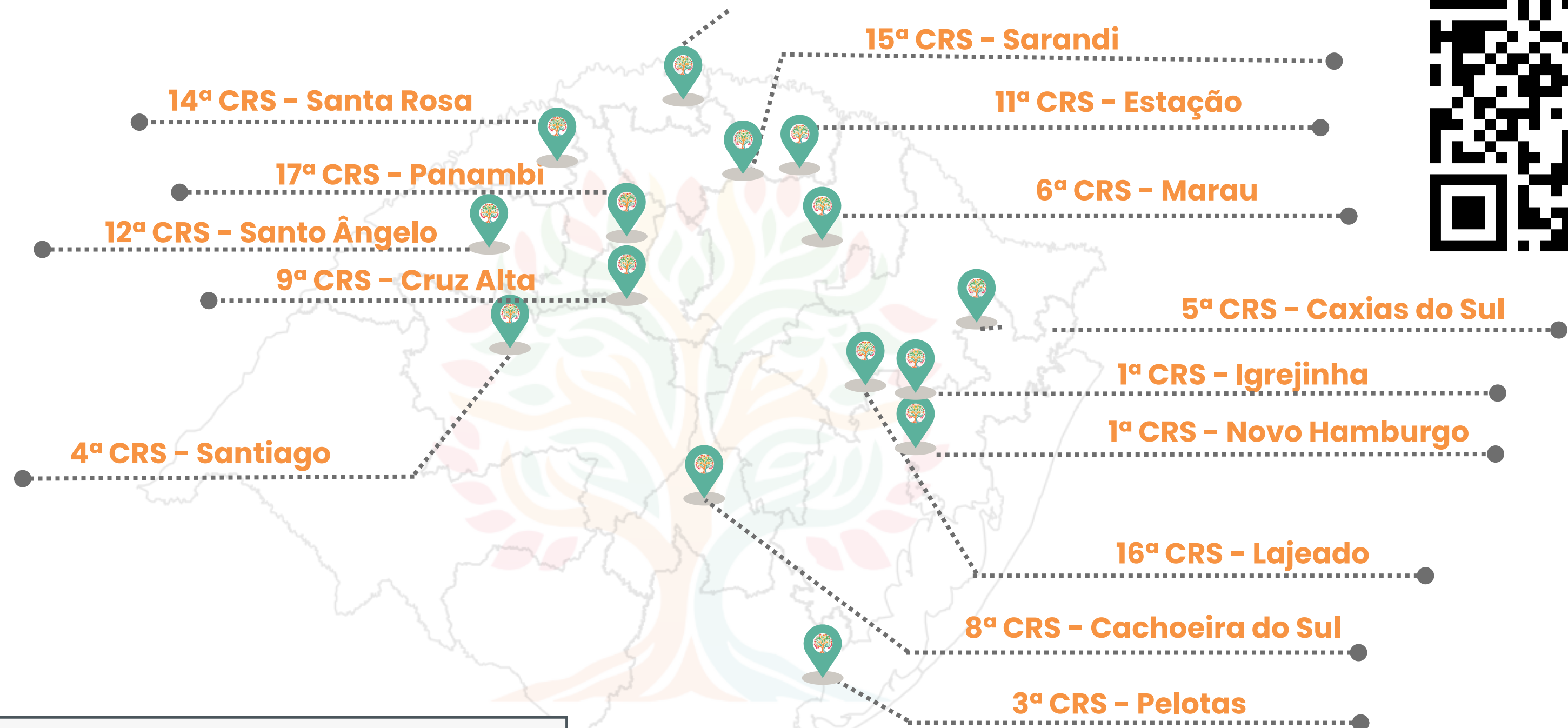
+2 profissionais 20h entre os núcleos:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| • Farmácia | • Nutrição |
| • Fonoaudiologia | • Gerontologia |
| • Terapia Ocupacional | |

+2 profissionais 20h entre os núcleos:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| • Farmácia | • Nutrição |
| • Fonoaudiologia | • Gerontologia |
| • Terapia Ocupacional | |





1ª CRS – Fundação de Saúde Pública
1ª CRS – Associação Beneficente de Igrejinha Mantenedora do Hospital Bom Pastor
2ª CRS – Ass. Hospitalar Beneficente Santo Antônio
3ª CRS – Cuidativa UFPEL
4ª CRS – Secretaria Municipal de Saúde
5ª CRS – Associação Cultural e Científica Virvi Ramos
6ª CRS – Ass. Hospitalar Beneficente de Marau

saude60mais-rs@saude.rs.gov.br

8ª CRS – Hospital de Caridade e Beneficência
9ª CRS – Secretaria Municipal de Saúde
11ª CRS – Hospital Santo Antônio de Estação
12ª CRS – Hospital Regional das Missões
14ª CRS – Fundação Municipal de Saúde
15ª CRS – Associação Hospitalar Vila Nova
16ª CRS – Hospital Bruno Born
17ª CRS – Associação Hospital Panambi

Estratégias para indução da AMD no RS

Saúde 60+ RS



- 15 serviços implementados em 2025
- Público-alvo são pessoas **idosas estratificadas como frágeis através da AMD** e/ou com suspeita ou diagnóstico de demência
- Papel matriciador da APS



Capacitações

- Ações de educação permanente às equipes da APS, gestores e serviços especializados (canal youtube, oficinas regionais)



Caderneta da Pessoa Idosa

- IVCF-20 na nova caderneta



Diálogo com estratégias adotadas pelo MS

- IVCF-20 no PEC eSUS
- Disparador para alcance dos indicadores de boas práticas



Como vai funcionar o indicador?

- **Percentual de Pessoas Idosas com registro do procedimento Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa**

Meta	Realizar avaliação multidimensional da pessoa idosa em 10% da população com 60 anos ou mais residente no município por seis competências*
Fonte	SISAB



*O período de mensuração será semestral, sendo o desconto aplicado na segunda competência do semestre subsequente.

Cálculo do Indicador

Nº de registros do procedimento de avaliação multidimensional em pessoas idosas do município

Nº de população idosa residente no município (RIPSA)

x 100



Como vai funcionar o indicador?

- Registro no Sistema de Informação

■ Procedimento

Procedimento: 03.01.09.003-3 - AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DA PESSOA IDOSA

Grupo: 03 - Procedimentos clínicos

Sub-Grupo: 01 - Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos

Forma de Organização: 09 - Atendimento/Acompanhamento em saúde do idoso

Competência: 01/2026

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial

Complexidade: Atenção Básica

Financiamento: Atenção Básica (PAB)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Individualizado)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 60 anos

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares: Exige CPF/CNS

Manual de aplicação e registro do IVCF-20 no PEC e-SUS APS

IVCF-20 no PEC e-SUS APS

Versão 5.3

FEVEREIRO 2025 Divisão da Atenção Primária à Saúde do RS



Valores

Como monitorar a realização de AMD no SISAB?

Para o monitoramento dos registros do procedimento de avaliação multidimensional da pessoa idosa realizados pelos municípios é necessário utilizar o relatório do SISAB - Saúde/Produção:

- Selecionar as competências a serem monitoradas (meses e ano);
- Selecionar a linha de relatório: município
- Selecionar a coluna do relatório: competência
- Selecionar tipo de produção: Procedimento
- Selecionar através do botão +SIGTAP o código referente à avaliação multidimensional (03.01.09.003-3)

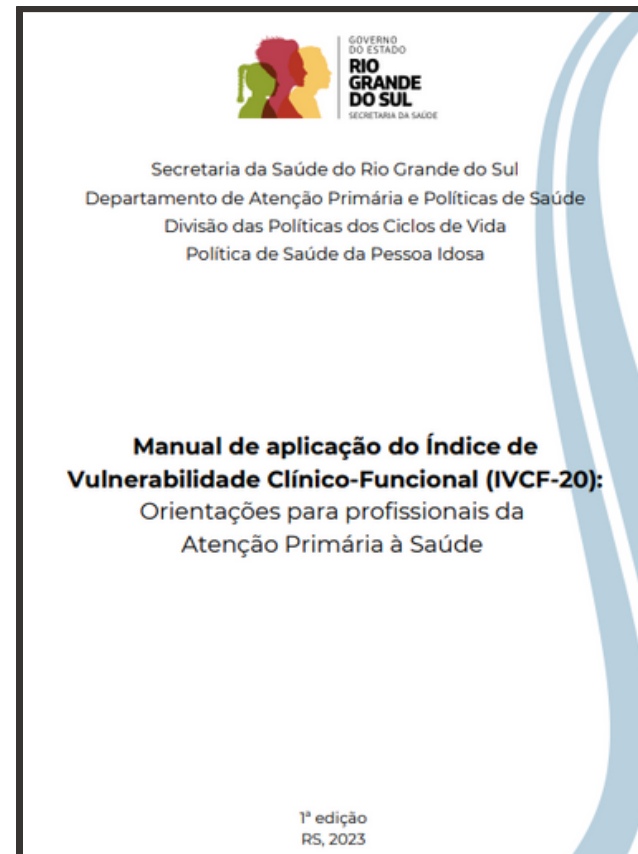
Dúvidas sobre o indicador?

saudedoidoso@saude.rs.gov.br



Materiais de apoio

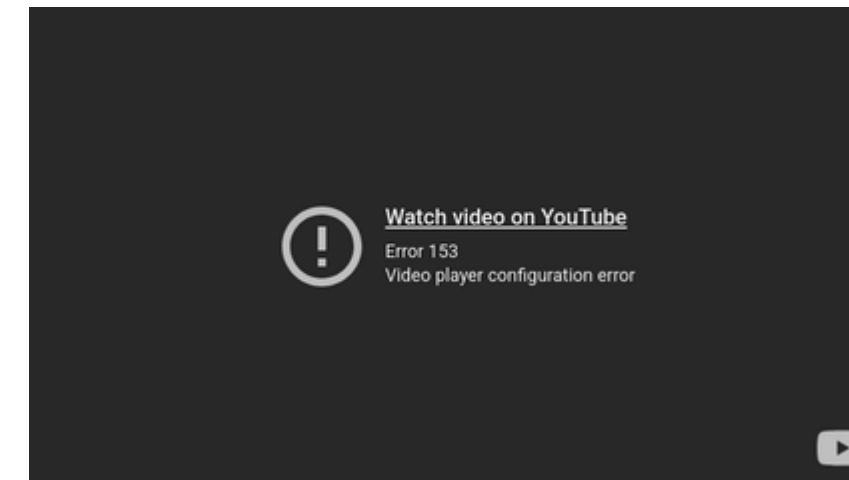
Manual IVCF-20



Capacitações no Youtube



Simulação da aplicação do IVCF-20 realizada pelo Núcleo de Geriatria e Gerontologia da UFMG



PERCENTUAL DE PESSOAS ENTRE 40 E 74 ANOS COM ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO CARDIOVASCULAR NA APS

Seção de Doenças de Condições Crônicas não Transmissíveis

III. Componente de incentivo para equipes da Atenção Primária à Saúde

Indicador nº5 (Novo)	Percentual de pessoas entre 40 e 74 anos com estratificação de risco cardiovascular na APS
Objetivo	Induzir a Estratificação de Risco Cardiovascular como ferramenta para identificar precocemente o risco de desenvolvimento de eventos cardiovasculares, contribuindo para adoção de medidas que possam reduzir e/ou evitar desfechos cardiovasculares fatais e não fatais.



Início do desconto no 1º semestre de 2027
Descontos referente à produção de 2026/02



Estratificação de Risco Cardiovascular (ERC)

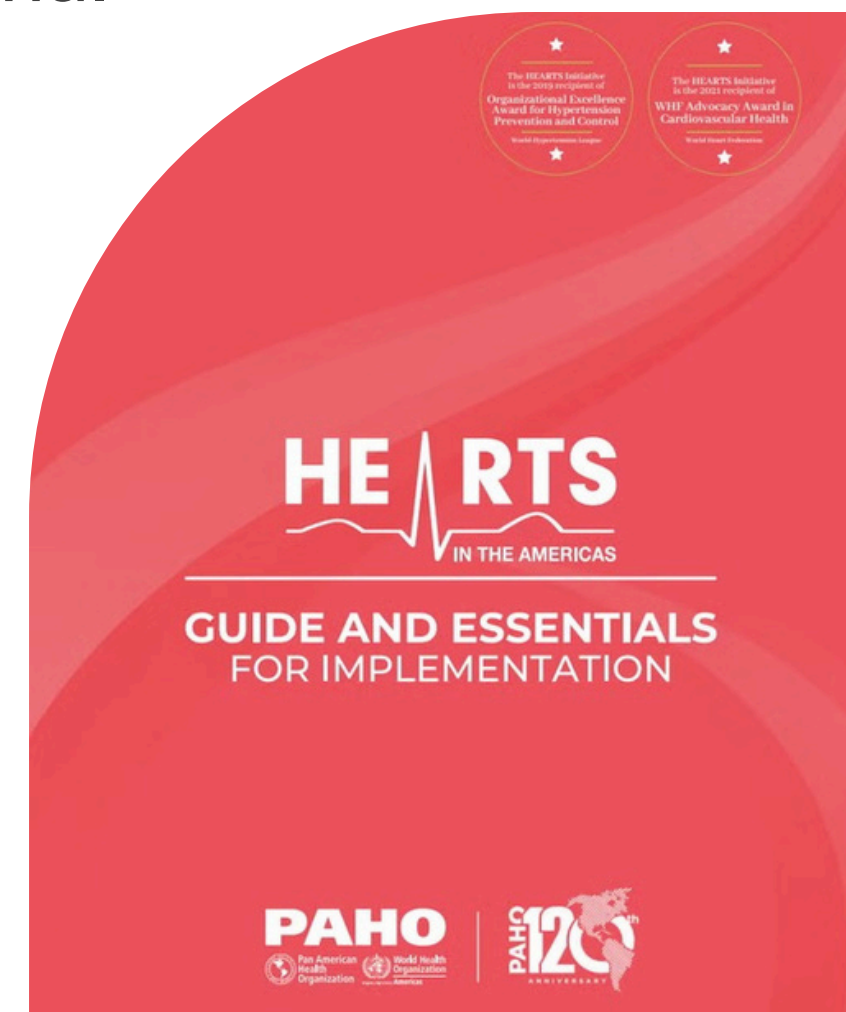
A ERC na APS para **pessoas de 40 a 74 anos** permite **identificar precocemente quem tem maior probabilidade** de desenvolver doenças como Infarto e AVC, direcionando intervenções preventivas.

A ERC organiza o fluxo assistencial, orienta a priorização do acompanhamento e otimiza o uso de recursos, garantindo maior equidade ao concentrar esforços nos indivíduos e territórios com maior risco. As orientações de cuidado após a estratificação são encontradas na [Nota Técnica Conjunta nº 05/2023 - Atenção ao Indivíduo com Hipertensão Arterial Sistêmica na Atenção Primária à Saúde.](#)



Estratificação de Risco Cardiovascular (ERCV)

Orientamos o uso da calculadora **HEARTS**, que é um instrumento **validado e calibrado para as características da população brasileira** (composição racial, condições socioeconômicas e ambientais), **considera fatores de risco amplamente disponíveis na APS**, avalia desfechos relevantes (infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral fatais e não fatais) e **é de fácil utilização**, o que corrobora a orientação para sua escolha.



Como vai funcionar o indicador?

- **Percentual de pessoas entre 40 e 74 anos com estratificação de risco cardiovascular na APS**

Meta	Realizar estratificação de risco cardiovascular em 10% das pessoas de 40-74 anos residentes no município.*
Fonte	SISAB

*O período de mensuração será semestral, sendo o desconto aplicado na segunda competência do semestre subsequente.

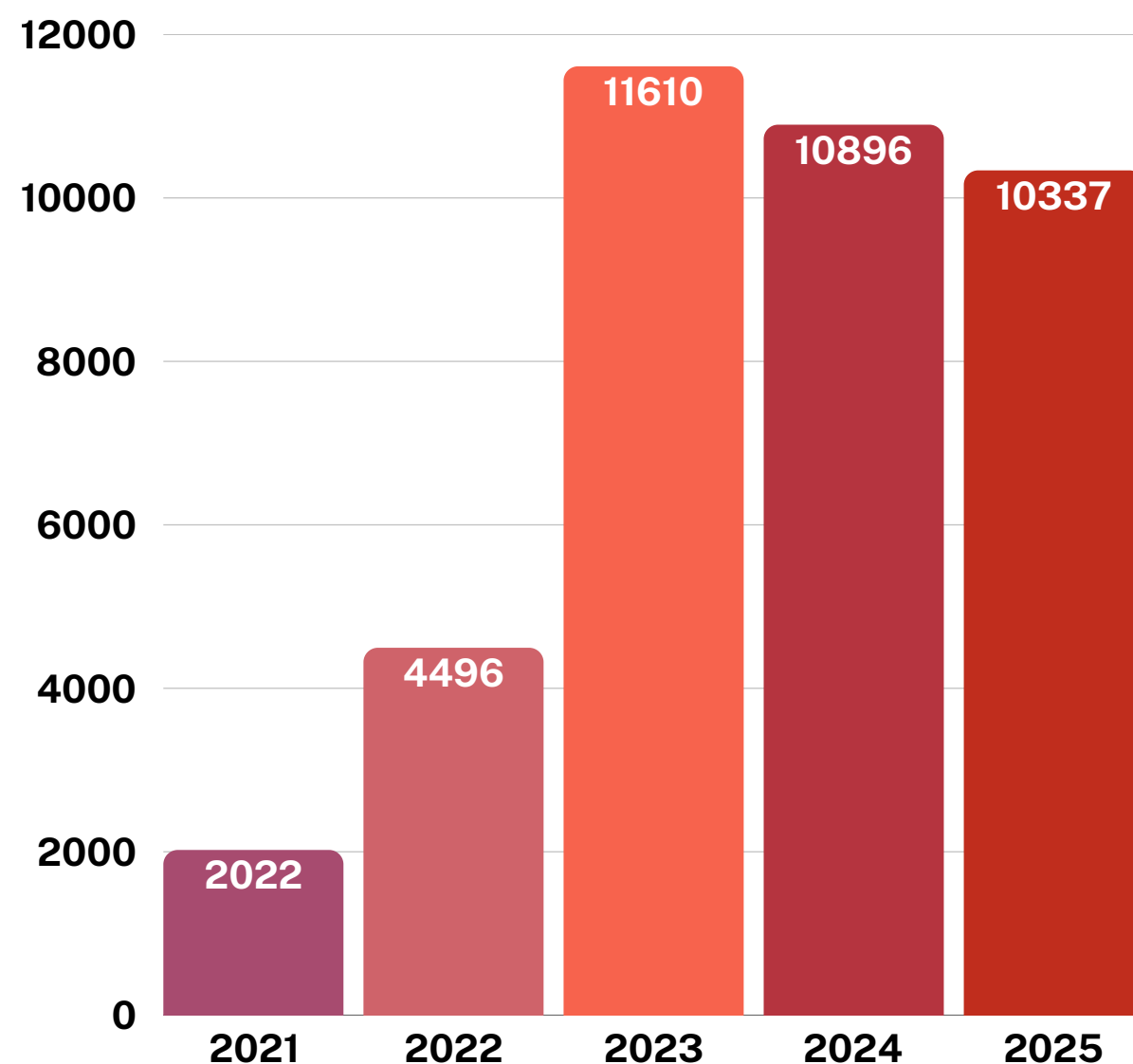
Cálculo do Indicador

$$\frac{\text{Nº de ERC realizadas em pessoas de 40-74 anos}}{\text{Nº de pessoas de 40-74 anos residentes no município}} \times 100$$



Ações de implementação da ECV no RS

Histórico da ECV no RS



*Fonte: SISAB - Dados extraídos em 20/01/2026.

Portaria GM/MS nº 3.008 de 4 de novembro de 2021.

- Institui a Estratégia de Saúde Cardiovascular na Atenção Primária à Saúde.

Portaria GM/MS nº 2.105 de 30 de junho de 2022.

Portaria GM/MS nº 2.110 de 30 de junho de 2022.

Nota Técnica Conjunta nº 05/2023 - Atenção ao Indivíduo com Hipertensão Arterial Sistêmica na Atenção Primária à Saúde.

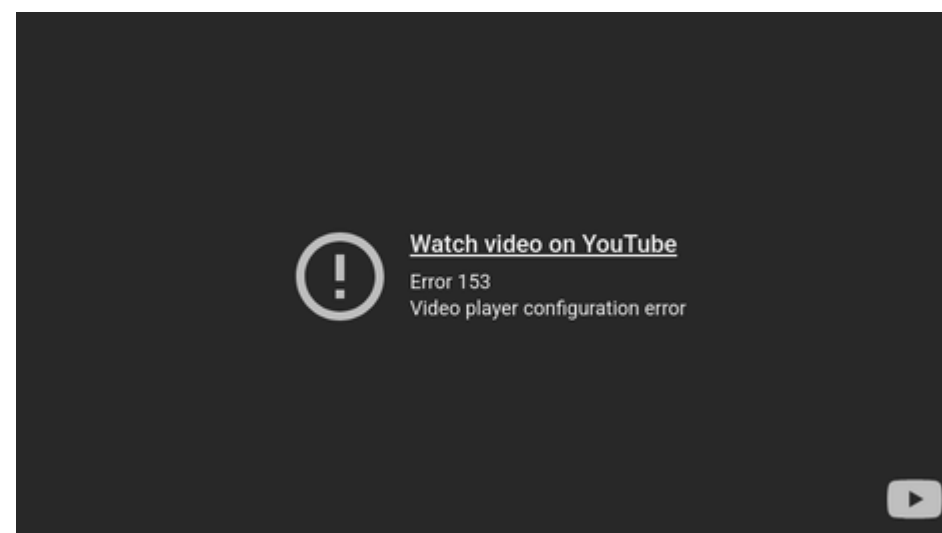
2021
104 municípios

2025
165 municípios

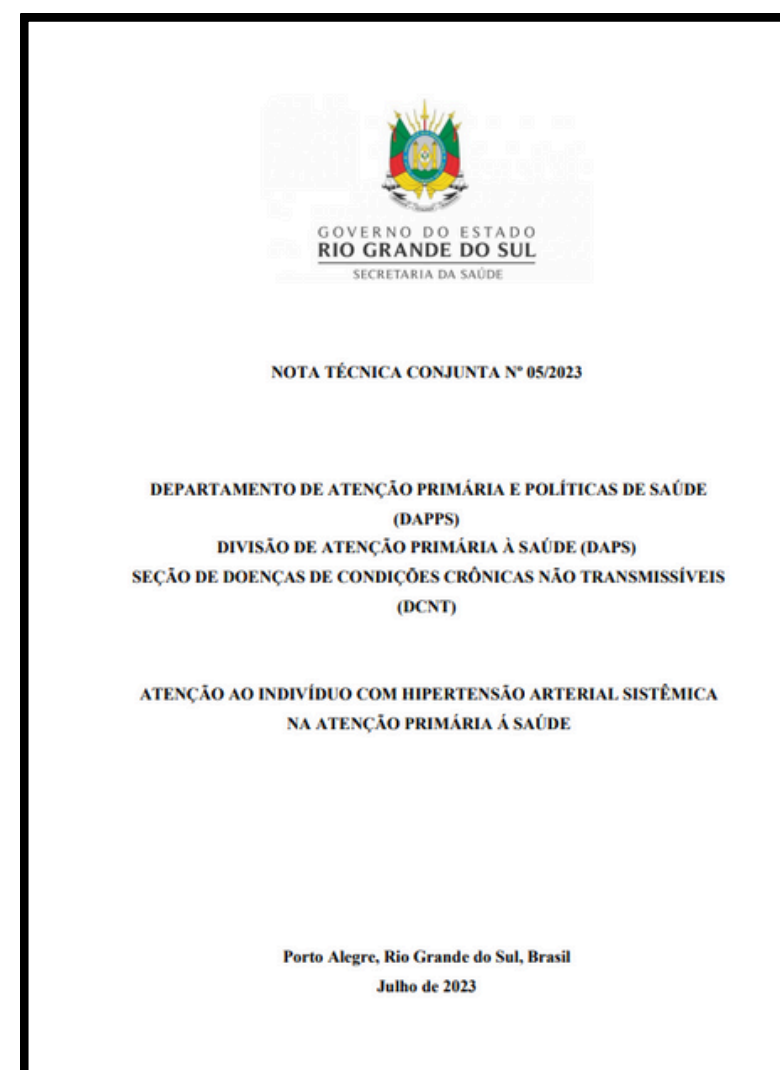


Materiais de apoio

Live – Planejamento do cuidado a partir da ERC



Nota técnica 05/2023



Calculadora HEARTS



Como monitorar a ERC no SISAB?

Para o monitoramento dos registros do procedimento de **estratificação de risco cardiovascular** realizados pelos municípios é necessário utilizar o relatório do SISAB - Saúde/Produção:

- Selecionar as competências a serem monitoradas (meses e ano);
- Selecionar a linha de relatório: município;
- Selecionar a coluna do relatório: **CIAP/CID** ou **SIGTAP**;
- Selecionar tipo de equipe: eSF (70) e eAP (76);
- Selecionar categoria profissional: Enfermeiro e Médico;
- Selecionar faixa etária: 40 a 74 anos;
- Selecionar através do botão:
 - **+CIAP/CID:** (Z136) Exame Especial de Rastreamento de Doenças Cardiovasculares
 - **+SIGTAP:** Estratificação do Risco Cardiovascular (03.01.01.038-2)
- Selecionar como deseja visualizar.

Dúvidas sobre o indicador?

cronicasrs@saude.rs.gov.br



PICS

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE-PICS

II. componente de incentivo para equipes da Atenção Primária à Saúde

Indicador 2	Percentual de equipes com registro de oferta de procedimentos, atendimento individual e atividade coletiva em PICS.	Meta: 25% do total de equipes de APS do município.
--------------------	--	---

Novidade: para compor os 25% das equipes consideradas no indicador, cada uma delas deverá registrar a oferta de práticas de PICS em, **no mínimo, três meses dentro de cada semestre**, alinhando-se ao período de avaliação do PIAPS, que ocorre semestralmente. Essa mudança visa garantir maior consistência e continuidade na oferta das práticas, promovendo a ampliação do acesso, o cuidado mais efetivo e integral à população.



PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE- PICS

II. componente de incentivo para equipes da Atenção Primária à Saúde

Indicador 2 Ano de referencia 2024	Atualmente: 120 municípios com equipe única: 117 (97,5%) atingem a meta 288 municípios com mais de uma equipe, 265 (92,01%) atingem a meta Total: 77% dos municípios na meta	Cenário proposto a partir de 2026: 120 municípios com equipe única: 87 (72,5%) atingem a meta 288 municípios com mais de uma equipe, 168 (58,33%) atingem a meta Total: 51% dos municípios na meta
--	---	---



ESTRATÉGIAS DE AÇÃO PARA ALCANCE DA META – INDICADOR PICS

- **Publicização do arcabouço legal que regulamenta as PICS no SUS – Âmbito do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde;**
- **Publicação de documentos orientadores para oferta de PICS no SUS – Notas Técnicas Orientadoras;**
- **Qualificação do processo de monitoramento das PICS – Guia de Monitoramento em PICS no RS;**
- **Publicização dos mapas de evidências e efetividade clínica das PICS - Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa;**
- **Publicização dos cursos disponíveis sobre PICS elaborados pelo Ministério da Saúde - plataforma AVASUS;**
- **Oferta de Qualificação Profissional em PICS: Auriculoterapia – PEPIC/RS e SUSTentaPICS/UFRGS.**



ESTRATÉGIAS DE AÇÃO PARA ALCANCE DA META – INDICADOR PICS

ACESSE OS CURSOS INTRODUTÓRIOS NO AVASUS:

[HTTPS://AVASUS.UFRN.BR/LOCAL/AVASPLUGIN/CURSOS/CURSOS.PHP?SEARCH=PICS](https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/cursos.php?search=pics)

Oferta de Qualificação Profissional em PICS:Auriculoterapia

- vagas reservadas para os profissionais de saúde de nível superior (eAPS, eSF, eMulti, eSB), dos municípios que não alcançaram a meta estabelecida no indicador 2 do Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde (PIAPS).
- Previsão de 2 turmas para o ano de 2026 (60 vagas)



Introdução às Práticas Integrativas e Complementares em Saúde: Shantala

UFRN / SEDIS / LAIS / CAV-UFPE / PNPIC / MS

O módulo de qualificação em Shantala é voltado para o fortalecimento de ações e serviços de PICS na Rede de Atenção à Saúde, por meio da promoção de conhecimento, interação e trocas de experiências na temática das PICS, com base nas diretrizes da Po

[Ver mais](#)



Introdução às Práticas Integrativas e Complementares em Saúde: Yoga

UFRN / SEDIS / LAIS / CAV-UFPE / PNPIC / MS

O módulo de qualificação em Yoga é voltado para o fortalecimento de ações e serviços de PICS na Rede de Atenção à Saúde, por meio da promoção de conhecimento, interação e trocas de experiências na temática das PICS, com base nas diretrizes da Po

[View more](#)



Introdução às Práticas Integrativas e Complementares em Saúde: Yoga

CAV-UFPE / UFRN / SEDIS / LAIS / PNPIC / MS

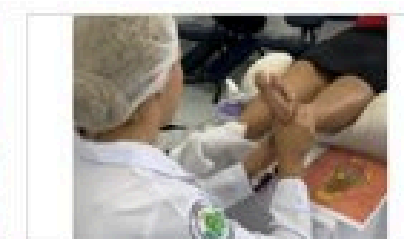
O módulo de introdução em Yoga foi elaborado em



Introdução às Práticas Integrativas e Complementares em Saúde: Aromaterapia

PNPIC / CAV-UFPE / UFRN / SEDIS / LAIS / MS

O Módulo Introdução às PICS: Aromaterapia está



Introdução às Práticas Integrativas e Complementares em Saúde: Reflexoterapia

UFRN / SEDIS / LAIS / CAV-UFPE / PNPIC / MS

A Reflexoterapia, também conhecida como



Curso de Qualificação da Saúde para Aplicação de Medicamentos e Fitoterapia

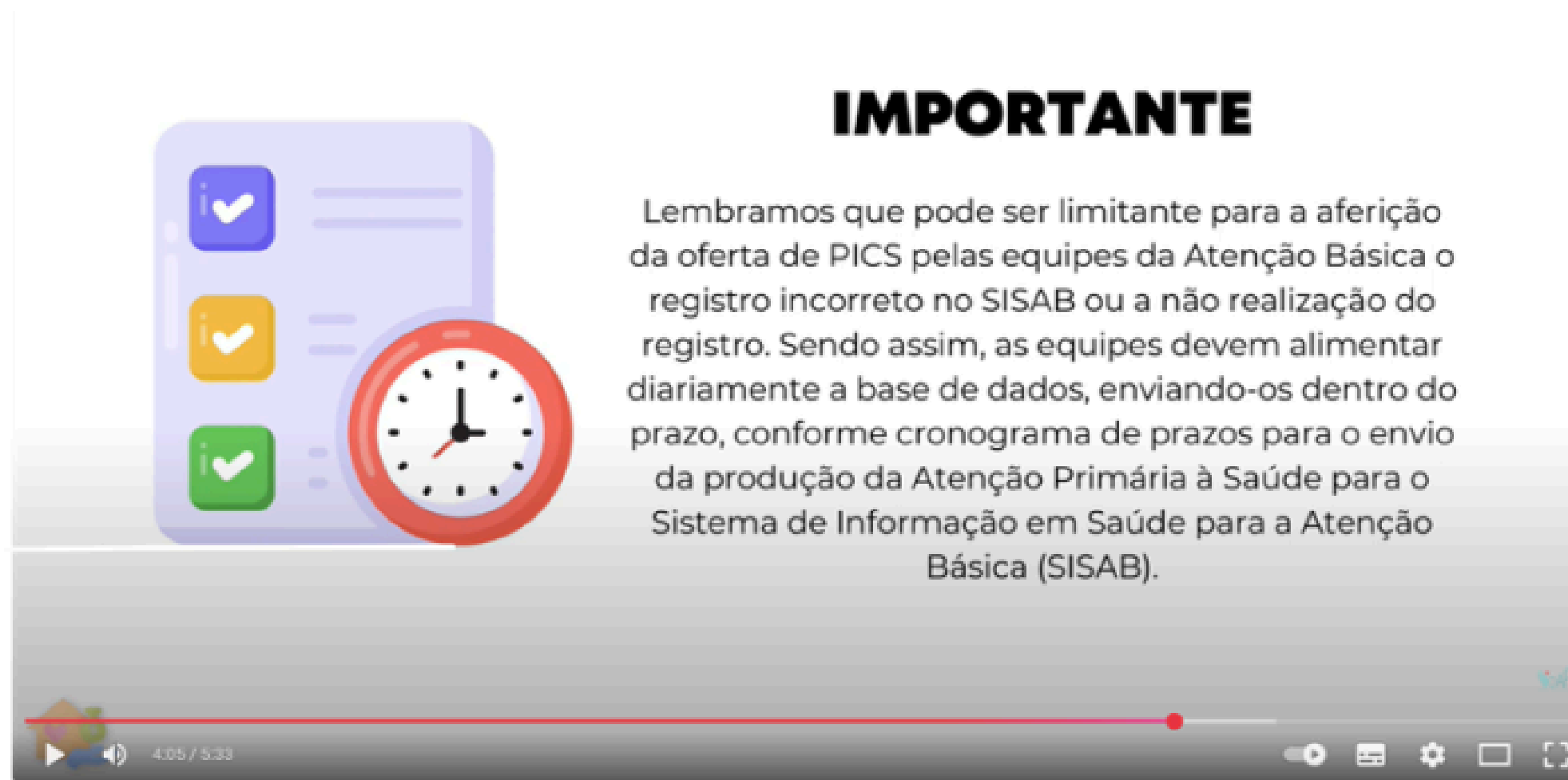
UFRN / SEDIS / LAIS / PNPIC / FIO

O curso de qualificação dos



ESTRATÉGIAS DE AÇÃO PARA ALCANCE DA META – INDICADOR PICS

Mais informações sobre registro e o indicador 2 do PIAPS

A video player interface. On the left, there is a graphic of a purple document with three colored checkboxes (purple, yellow, green) each containing a white checkmark, and a red analog clock. On the right, the word 'IMPORTANTE' is written in bold black letters. Below it, a paragraph of text explains that a common limiting factor for the verification of PICS offer by Basic Attention teams is incorrect registration in SISAB or non-registration. It advises teams to feed the database daily and send data within the deadline according to the schedule for sending primary health production data to the SISAB system.

IMPORTANTE

Lembramos que pode ser limitante para a aferição da oferta de PICS pelas equipes da Atenção Básica o registro incorreto no SISAB ou a não realização do registro. Sendo assim, as equipes devem alimentar diariamente a base de dados, enviando-os dentro do prazo, conforme cronograma de prazos para o envio da produção da Atenção Primária à Saúde para o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB).

Indicadores de pagamento por desempenho do PIAPS/RS - Indicador 2



ESTRATÉGIAS DE AÇÃO PARA ALCANCE DA META – INDICADOR PICS



Mapas de Evidências

Como contribuição para facilitar o acesso às evidências disponíveis, bem como à identificação de lacunas no conhecimento, o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIN) e BIREME/OPAS/OMS uniram esforços para sistematizar as evidências científicas em Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas – MTCI em mapas de evidências; com o objetivo de apoiar profissionais de saúde, tomadores de decisão e pesquisadores na construção de ações de saúde baseadas em evidências.

COMO UTILIZAR OS MAPAS DE EVIDÊNCIA?

Conheça os Mapas de Evidências em MTCI:

<https://cabsin.org.br/mapas-de-evidencias/>



Mapas de Evidências

Efetividade Clínica das Plantas Medicinais Brasileiras



ESTRATÉGIAS DE AÇÃO PARA ALCANCE DA META – INDICADOR PICS

- **Dúvidas, apoio:**

Equipe PEPIIC: Alpheu Ferreira do Amaral Jr.
Lisiane Löbler

Referências Regionais nas 18 CRS

E-mail: pepic@saude.rs.gov.br





PERCENTUAL DE EQUIPES QUE REALIZARAM PELO MENOS 1 (UM) ATENDIMENTO EM GRUPO RELATIVO AO TEMA DE SAÚDE MENTAL

Política Estadual de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas

III. Componente de incentivo para equipes da Atenção Primária à Saúde

Indicador 3

Percentual de equipes da Atenção Básica que realizaram pelo menos 1 atendimento em grupo relativo ao tema de saúde mental.



Cálculo do Indicador III

Município	Nº Equipes ESF	Nº Equipes EAP	Total de equipes pagas	% das equipes conforme corte populacional	Meta Nº equipes
<30 mil hab. (75% equipes)	1	2	3	2,25 (3x75/100)	2
>30 mil hab. (50 % equipes)	5	0	5	2,50 (5x50/100)	3

Exemplo: o município de Garibaldi (34 mil hab.) tem 5 (cinco) equipes, então 3 (três) delas precisam fazer no mínimo 1 (uma) atividade em grupo com o tema da saúde mental no semestre.

NOVIDADE

- Redução da quantidade de atividades realizadas por equipe - redução de 4 para 1
- Redução das faixas populacionais de 5 para 2, facilitando a compreensão e o cálculo do indicador. Cálculo igual ao indicador Alimentação Saudável.



O que mudou?

Ficou mais fácil de alcançar a meta!

Novas faixas populacionais:

- **75% das equipes da AB realizaram pelo menos uma (01) atividade coletiva com o tema de saúde mental no último semestre para os municípios com até 30.000 habitantes.**
- **50% das equipes da AB realizaram pelo menos uma (01) atividade coletiva com o tema de saúde mental no último semestre para os municípios com mais de 30.000 habitantes.**

Redução do numero de atividades:

- **Nova meta:** Uma atividade em grupo com tema saúde mental realizada por equipe dentro do semestre.

Exemplo:

Ametista do Sul: 7 mil habitantes, se encaixa na faixa de 75%, tem 4 equipes ESF. Se 3 das 4 equipes registrarem uma atividade em grupo de saúde mental dentro do semestre, atingiram a meta.



ORIENTAÇÕES SOBRE ATENDIMENTOS EM GRUPO RELATIVOS AO TEMA DA SAÚDE MENTAL

- Por que grupos?
- O que caracteriza um grupo?
- Tipos de grupos e metodologias.
- Como identificar a necessidade de um grupo?
- Quando e como criar um grupo de saúde mental?
- O que torna um grupo espaço de cuidado em saúde mental?
- Quem é responsável por conduzir os cuidados em saúde mental na APS?



Secretaria de Estado da Saúde
Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde
Divisão de Políticas Transversais
Política Estadual de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas

Nota Técnica nº 08/2023 - Política Estadual de Saúde Mental

ASSUNTO: Orientações para a realização de atendimentos em grupo com o tema de saúde mental, com vistas ao cumprimento da meta relacionada ao indicador de número '3' do Programa Estadual de Incentivos para a APS (PIAPS) do Rio Grande do Sul.

O INDICADOR:

Percentual de equipes da Atenção Básica (INE) que realizaram pelo menos 4 (quatro) atendimentos em grupo relativos ao tema da saúde mental ao longo de um semestre.

Esse indicador mede a quantidade de ações em grupo para a prevenção e promoção de saúde mental, voltadas à população geral do território ou para pessoas com demandas de saúde mental. O objetivo desse indicador é mensurar o percentual de equipes da Atenção Primária à Saúde (APS) em cada município que promovem regularmente ações de cuidado em saúde mental, com o intuito de garantir o acolhimento, o planejamento, o vínculo e a longitudinalidade do cuidado às pessoas usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), independentemente de sua classificação diagnóstica.

A quantidade de quatro atendimentos tem como objetivo fomentar o desenvolvimento, a implementação, a organização e a regularidade das ações de saúde mental nos municípios, considerando que, ao longo de um semestre, essa quantidade de ações pode ser realizada tanto por municípios que já possuem grupos sistemáticos quanto por aqueles que pretendem iniciar essa prática.

Para informações sobre o registro do indicador, acessar o passo a passo no material "Guia orientador para registro dos cinco indicadores do PIAPS", disponível em: <https://admin.atencaobasica.rs.gov.br/upload/arquivos/202208/25124219-guia-registro-indicadores-piaps-2.pdf>.

Para acessar os resultados do seu município ou região de saúde, acessar o painel PIAPS no BI, disponível em: https://ti.saude.rs.gov.br/piaps_bi/.

JUSTIFICATIVA

A nota informativa nº 03/2023 "Indicadores DAPPS/PIAPS" apresenta as fichas de qualificação para cada um dos indicadores que compõem o PIAPS, bem como detalha o método de aferição e avaliação. O presente documento tem como escopo subsidiar o processo de trabalho das equipes em relação ao indicador 3.

Nota Técnica nº 08/2023



Lançamento de card orientativo com exemplos, destacando que a atividade coletiva de saúde mental não é uma atividade a mais, mas sim uma atividade que a APS já faz.

CONTATOS

Fone: (51) 3288-5908/ 3288-5909/ 3288-7961

E-mail:
saudemental@saude.rs.gov.br



SECRETARIA DA
SAÚDE

Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde - DAPPS
Divisão de Políticas Transversais
Política de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas

INDICADOR
3

SAÚDE MENTAL
Este material tem como objetivo fornecer orientações para o alcance do Indicador 3 do **Programa Estadual de Incentivos para a Atenção Primária à Saúde (PIAPS)**, que corresponde ao percentual de equipes da Atenção Primária à Saúde que realizaram, no mínimo, uma atividade com a temática de **saúde mental**.



» O que é o Indicador 3 do PIAPS?
É o indicador que mensura o percentual de equipes da Atenção Básica, contabilizado através do Identificador Nacional de Equipe (INE), que realizaram pelo menos 1 (uma) **atividade coletiva com o tema de SAÚDE MENTAL** ao longo de um semestre.



A saúde mental coletiva não é uma atividade a mais que a APS precisa fazer. É uma atividade que a APS já faz. Saiba como:



- Rodas de chimarrão;
- Rodas de conversa na praça;
- Atividades artísticas e/ou de expressão emocional em grupo;
- Grupos de públicos específicos em situação de vulnerabilidade para questões de saúde mental: como gestantes, crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas com doenças crônicas;
- Apoio emocional a casais grávidos;
- Grupos de promoção à saúde que envolvam temas relacionados à saúde mental, como: parentalidade, masculinidades, gênero, convivência, etc;
- Caminhadas em grupo, dentre outros exemplos.

Link para a Nota Técnica:



Reconheceu uma destas atividades em prática no seu município? Então REGISTRE no e-SUS APS.



É possível acompanhar o passo a passo para o registro por meio do Guia Registro indicadores PIAPS:



O registro só vai contabilizar para a equipe em que o profissional estiver lotado.
Todos os profissionais da equipe podem desenvolver atividades coletivas com a temática de saúde mental, conforme suas atribuições.

É importante que, por exemplo, o(a) agente comunitário(a)/técnico(a) em agente comunitário(a) de saúde ou técnico(a) de enfermagem participem do grupo e registrem a atividade para contabilizá-la para a sua equipe.





ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Política de Alimentação e Nutrição



II. Componente de incentivo para equipes da Atenção Primária à Saúde

Indicador 1	Percentual de equipes da Atenção Básica que realizaram pelo menos 1 (uma atividade com o tema alimentação saudável)	Meta: 75% do total de equipes para municípios com até 30.000 hab. 50% do total de equipes para municípios com mais de 30.000 hab.
--------------------	--	--

Exemplo

Municípios	Total Equipes Pagas	% das equipes conforme corte populacional	Meta Nº equipes
< 30 mil hab. (75 % equipes)	3	2,25 (3 x 75 / 100)	2
> 30 mil hab. (50 % equipes)	5	2,5 (5 x 50 / 100)	3



ESTRATÉGIAS DE AÇÃO PARA ALCANCE DA META – INDICADOR

- **Apoio Técnico às Regionais de Saúde e Municípios nas ações de alimentação e nutrição (planejamento, identificação de ações desenvolvidas nas equipes, como realizar o registro da atividade no sistema da APS , destacando que deve ser dentro do mês que foi realizada...);**
- **Orientação para realizar as atividades de alimentação saudável (Educação em saúde, atendimento em grupos e mobilização sociais (espaços comunidades), datas comemorativas e outros ;**
- **Capacitação marcadores de consumo alimentar e avaliação do estado nutricional (Relatórios Sisvan e registro no e-SUS); cursos em parceria com UFSM- site do Observatório de Vigilância Alimentar e Nutricional -OVAN;**
- **Realização do IV Encontro Estadual de Ações de Alimentação e Nutrição na Atenção Primária à Saúde: Segurança Alimentar e Nutricional, Santa Maria, junho 2025;**
- **Capacitação de multiplicadores na abordagem individual para manejo da obesidade no SUS, com o Grupo Condutor Estadual e Municipais da Linha do Cuidado Sobrepeso e Obesidade, outubro 2025;**
- **Realização do 2º Encontro Estadual da Estratégia Amamenta Alimenta Brasil (Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável), agosto 2025;**



ESTRATÉGIAS DE AÇÃO PARA ALCANCE DA META – INDICADOR

- Reprodução e distribuição na APS, do Guia Alimentar da População Brasileira, Guia de Crianças Brasileiras Menores de dois Anos e a Matriz para Organização dos Cuidados em Alimentação e Nutrição na Atenção Primária à Saúde para qualificar as equipes da APS na oferta dos cuidados em alimentação e nutrição de acordo com as necessidades de saúde da população.

Observatório de Vigilância Alimentar e Nutricional (OVAN). Materiais disponíveis:

- II Edição do e-book "Ações de Alimentação e Nutrição na APS: relatos de experiências de municípios gaúcho": <https://www.editorafi.org/ebook/c076-acoes-alimentacao-nutricao-atencao-primaria-saude>
- Chatbot - Assistente Virtual do Observatório de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan: <https://ovanufsm.github.io/chatbot/>



ESTRATÉGIAS DE AÇÃO PARA ALCANCE DA META – INDICADOR

Exemplo publicações de apoio:



Política de Alimentação e Nutrição

Apoio, demandas e esclarecimento de dúvidas :

Equipe PAN

**Deise Vetromilla
Maísa Beltrame Pedroso
Maria Alice Lantmann**

Referências Regionais da PAN

E-mail: pan@saude.rs.gov.br



SECRETARIA DA
SAÚDE



GOVERNO
DO ESTADO
**RIO
GRANDE
DO SUL**

PERCENTUAL DE GESTANTES COM PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO ADEQUADO PARA SÍFILIS CONFORME A CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA

PERCENTUAL DE GESTANTES COM PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO ADEQUADO PARA SÍFILIS CONFORME A CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA

II. Componente de incentivo para equipes da Atenção Primária à Saúde

Indicador 4	OBJETIVO: Mensurar e monitorar quantos casos notificados de gestantes com sífilis recebem a prescrição do tratamento adequado das gestantes com sífilis.	PARÂMETRO: 100% dos casos de SG com prescrições adequadas. META: 80% dos casos SG. FONTE: SINAN.
--------------------	---	---

Fórmula de Cálculo

$$\frac{\text{nº de casos notificados de SG com prescrição adequada de tratamento conforme a fase clínica}}{\text{nº total de casos notificados de SG}} \times 100$$



Início do desconto no 1º semestre de 2027
Descontos referente à produção de 2026/02



ESTRATÉGIAS

- Fomentar a utilização dos protocolos clínicos e de diretrizes terapêuticas vigentes para a prevenção da Transmissão Vertical da Sífilis com diagnóstico em tempo oportuno e realização da notificação no SINAN.
- Implantação e implementação da Linha de Cuidado para as Pessoas Vivendo com HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).
- Incentivar a criação de um plano contínuo de Educação para os profissionais da assistência com ênfase na atualização dos fluxos de vigilância, diagnóstico e tratamento da sífilis, inclusive divulgando os diversos cursos oferecidos.
- Estimular a articulação/parceria da rede de serviços (saúde, educação e assistência social) para a prevenção da sífilis e outras ISTs.

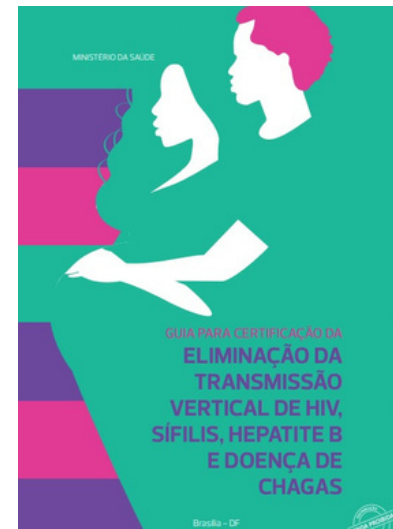


ESTRATÉGIAS

- Incentivar a ampliação da oferta de testagem rápida, em livre demanda, do HIV, Hepatites Virais e Sífilis como rotina nos serviços de saúde para toda a população.
- Analisar a proporção de testes realizados pela população, a fim de verificar a cobertura, criando estratégias para que toda população tenha acesso
- Estimular a implantação e implementação dos Comitês (Regional e Municipal) de Investigação da Transmissão Vertical.
- Monitorar e acompanhar os casos de gestantes com diagnóstico de sífilis.
- Incentivar o uso do sistema SALUS - de vigilância e gestão de casos da sífilis.
- Planejar juntamente com os municípios estratégias para alcançar a eliminação da transmissão vertical.
- Relacionar as bases de dados (sífilis em gestante e congênita) com objetivo de identificar subnotificação, **reduzindo assim o número de municípios "silenciosos"**.



MATERIAIS DE APOIO



DÚVIDAS E APOIO:

SEÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS TRANSMISSÍVEIS
COORDENAÇÃO ESTADUAL DE IST E AIDS

EQUIPE NÚCLEO DE VIGILÂNCIA DO HIV/AIDS, SÍFILIS E HTLV

ALINE L. SILVEIRA
TATIANA HEIDI

TEL: (51) 3288-5910
sinan-aids@saude.gov.br



Obrigada

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E POLÍTICAS DE SAÚDE



 /governodoRS

 @governo_rs

 @governodo_rs

 /governors

SECRETARIA DA
SAÚDE



GOVERNO
DO ESTADO
**RIO
GRANDE
DO SUL**